

国健医疗

四诊合参体质辨识报告

开封市龙亭区 1234452345

患者信息：

姓名：	士大夫	性别：	男	年龄：	20岁	生日：	2006-04-05
住址：	法国岁的法国士大夫的						

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）



舌苔图

核心证候为脾虚湿盛兼轻度气阴两虚。舌质淡红偏淡，舌体略胖、边有轻微齿痕，苔薄白润，舌面湿润无燥裂，提示脾失健运、水湿内停；舌尖稍红、舌中根部略显淡，反映中焦气虚兼轻度虚热。建议：①饮食宜温补健脾，如山药、莲子、薏苡仁煮粥；②忌生冷油腻及甜食，以防助湿伤脾。

补充分析

- 舌象结果已提示当前舌体与舌苔特征，建议与饮食、睡眠、情绪状态一起观察。
- 这类表现通常和运化偏弱、湿邪偏重有关，日常可留意清淡饮食与作息规律。
- 目前变化偏轻，重在早期干预和持续观察，避免继续累积疲劳与饮食失衡。
- 如果后续还有闻诊、问诊或切诊结果，可进一步提高整体辨证的稳定性。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：气虚质
置信度：90.3%

体质标签：

气力不足

声音偏弱

声带振动不规则

补充分析

- 当前闻诊置信度为 90.3%，可作为参考，但不建议单独定性。
- 体质标签显示：气力不足、声音偏弱、声带振动不规则，说明声音特征与当前体质倾向存在一定关联。
- 若日常出现乏力、气短、咳嗽或情绪波动，建议结合具体症状继续观察。

问诊（症状问卷）

专项问诊结论

阴虚质、湿热质

平和质

体质总体协调，阴阳气血较为平衡，日常以维持稳定作息和均衡饮食为主。

补充分析

- 本次得分靠前的是：candidateConstitutions0分、mainConstitution0分、scores0分，可作为后续调理重点。
- 问卷分析适合与望诊、闻诊和切诊结果联动解读，不宜单独下结论。
- 若主诉症状持续存在，建议结合睡眠、饮食、情绪和运动习惯一起评估。

饮食建议

- 三餐规律，饮食均衡，不偏食
- 谷物、蔬菜、优质蛋白搭配摄入
- 保持清淡适度，避免长期暴饮暴食

禁忌提醒

- 避免长期熬夜
- 避免过度劳累和久坐不动
- 避免饮食过于油腻或极端节食

后续建议

- 坚持每周适量运动
- 保持情绪平稳，规律作息
- 定期体检，动态观察体质变化

切诊（脉搏检测）

心率：82.6 bpm

血氧：99.5 %

信号有效率：98.7 %

采样数：148

中医建议：

【结论性质】本结果基于PPG自动分析，仅反映当前时段脉搏特征倾向，不等同于临床确诊。【融合判定】缓脉倾向（多特征融合）【区分度】主次得分差=1.0（越高表示判定越稳定）【融合得分】数=0.6，迟=0.5，缓=1.6【脉象倾向】缓脉范围（心率中等）【脉搏特征】缓脉倾向、节律轻度不齐、脉势偏弱、证据：心率中段(82.6bpm)、证据:HRV偏高(RMSSD=102.641ms, SDNN=53.523ms)、证据:灌注偏弱(PI=0.4759)【量化摘要】RMSSD=102.641ms, 节律CV=0.0918, 灌注指数PI=0.4759%。

补充分析

- 当前心率 82.6 bpm、血氧 99.5%，可作为循环与呼吸状态的基础参考。
- 信号有效率 98.7%、采样数 148，说明本次测量质量具备一定参考价值。
- 脉搏分析已给出中医建议，可与舌象和问卷结果一起综合判断。

AI 详细分析

不侧重模式下，只输出补充性的 AI 结论、风险提示和后续建议。

好的，作为资深中医四诊合参医生，我将基于您提供的全部数据，遵循分析规则，为您提供一份综合诊断报告。

AI 分析建议与综合诊断报告

患者：士大夫 | 性别：男 | 年龄：20岁

一、核心发现摘要

- 核心证候为“脾虚湿盛，兼有气阴两虚”。证据链清晰：舌象（舌淡胖有齿痕、苔白润）指向脾虚湿盛；闻诊（气虚质标签）与切诊（脉势偏弱）支持气虚；问卷（阴虚质高分）与舌象（舌尖稍红）提示轻度阴虚。
- 体质呈现“气虚质”与“阴虚质”并存的复合偏颇状态。闻诊算法明确指向“气虚质”，问卷算法则显示“阴虚质”与“湿热质”得分最高，但舌象未见典型湿热（苔黄腻指数低），故阴虚证据更可靠。

3. 当前生理机能处于“代偿期”，但已显疲弱之象。脉搏虽在正常范围，但呈现“缓脉倾向、脉势偏弱、节律轻度不齐”，结合HRV偏高，提示身体处于一种“欲振乏力”的亚健康状态，自主神经调节可能已受影响。
4. 调理关键在于“健脾化湿”以治其本，“益气养阴”以顾其标。需避免过度清热或滋腻，以防进一步损伤脾胃阳气。

二、四诊数据交叉验证分析

1. 望诊（舌象）分析

- 算法结论：脾虚湿盛兼轻度气阴两虚。
- 证据链解读：
 - 舌色偏淡指数高（65）：是“气虚”、“阳虚”或“血虚”的客观量化证据，支持气虚判断。
 - 舌色偏红指数中等（40）：结合“舌尖稍红”的算法描述，提示上焦或心肺部有轻微虚热，这与“阴虚质”问卷结果相呼应。
 - 苔色黄腻指数极低（10）、津液亏虚指数低（15）：有力排除了典型的“湿热”和“津伤”证候，说明体内湿邪性质偏“寒湿”，且阴伤不重。这修正了问卷中“湿热质”的单一判断。
- 简要建议：舌象是脾虚湿盛的核心证据，调理需以温运健脾、淡渗利湿为主。

2. 闻诊（音频）分析

- 算法结论：气虚质（置信度高，0.90）。
- 证据链解读：模型标签“气力不足、声音偏弱”直接对应中医“气虚”证候。音频特征中较低的rmsEnergy（能量）和voicedRatio（浊音比率）从声学信号层面支持“中气不足”的判断。
- 简要建议：闻诊结果与舌诊的“气虚”指向一致，增强了气虚诊断的可靠性。应避免耗气伤神的长时间说话或大声喊叫。

3. 问诊（问卷）分析

- 算法结论：阴虚质、湿热质。
- 证据链解读：“阴虚质”得分最高（14分），与舌象“舌尖稍红”的虚热征象部分吻合。“湿热质”虽同分，但舌象未见黄腻苔，因此其表现可能被脾虚湿盛所掩盖，或热象不显。其他体质分数接近，提示体质偏颇情况复杂。
- 简要建议：问卷提示了“阴虚”倾向，但在制定方案时，需以客观舌脉为依据，养阴而不助湿。

4. 切诊（脉象）分析

- 算法结论：缓脉倾向、脉势偏弱、节律轻度不齐（数据质量高）。
- 证据链解读：心率正常偏缓（82.6bpm），但HRV偏高（RMSSD=102.641ms），结合“脉势偏弱”，符合“气虚无力鼓动血脉”的脉象特征。“节律轻度不齐”提示心气可能略有紊乱。灌注指数偏低（PI=0.4759%）从微循环角度支持“气血推动力不足”的判断。
- 简要建议：脉象是气虚的又一有力佐证。缓而弱的脉象适合温和的补益调理，切忌峻补。

三、综合辨证与依据

- 主要证候：脾虚湿盛证为本，气阴两虚证为标。
- 核心依据：
 1. 脾虚湿盛：舌淡胖有齿痕（望诊）、苔白润（望诊）、脉缓弱（切诊）构成核心证据三角。
 2. 气虚：声音低弱（闻诊）、脉势偏弱（切诊）、舌色偏淡（望诊）多维度印证。
 3. 阴虚（轻度）：体质问卷高分（问诊）、舌尖稍红（望诊）提供支持，但舌面不燥、津液指数正常，说明阴伤较轻，热象为虚热。

四、可执行调理方案

1. 饮食建议

- 主食：多吃小米、薏米、山药、莲子熬粥，健脾祛湿。

- **菜肴**：适量食用白扁豆、茯苓、鲫鱼、南瓜。烹饪以炖、煮、蒸为主，少用油炸。
- **禁忌**：严格限制生冷瓜果、冰镇饮品、油腻甜食（如糕点、奶茶），以免加重湿困脾胃。

2. 作息与情志

- **作息**：保证子时（23点前）入睡，避免熬夜耗伤气阴。午间可小憩15-30分钟以养心神。
- **情志**：避免思虑过度，因“思伤脾”。可通过听舒缓音乐、散步等方式放松心情。

3. 运动建议

- **原则**：选择温和、持续、微汗的运动，忌大汗淋漓。
- **推荐**：每日快走30-45分钟、八段锦、太极拳。以运动后感觉身体轻松、不疲劳为度。

五、数据缺口与补充建议

本次四诊数据完整，质量较高，无缺失板块。基于现有分析，**无需额外补充检查**。建议按照上述方案调理1-2个月后，复测舌象与脉象，以评估调理效果并动态调整方案。

免责声明：本报告基于AI算法对四诊信息的分析与融合推理，仅供参考，不能替代执业医师的面对面诊断。若出现不适，请及时就医。

报告生成时间：2026/4/12 16:07:38

本系统仅为中医诊断辅助工具，不具备医疗资质，输出结果仅供参考，不能替代专业中医师面诊及诊疗方案

签发医师：张翰

3个月